

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231697082/608

OTAVIO AUGUSTO MARTINS SOUSA LOPES ROSADO

IDADE: 32 PESO: 91 ALTURA: 1,76 PROFISSÃO: Empresário

SINTOMAS: Cansaço diurno, Dorco, fadiga

QUEIXAS: Desconcentração

MEDICAMENTOS: Adipet Aramis

MÉDICO: Dra Priscila Silveira (Otorino)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20:30-21:30

HORA QUE DORME: 22h-23h HORA QUE ACORDA: 6h - 6:30h

COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Rual BANHEIRO: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: III

IAH: 38,2

SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

IMC:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

08/08 Avaliação Marc. D. Wear.

16/08/24 P=6-8,6 cmH₂O | fixo P=8,6 cmH₂O

TAH=3,4 e/h

m de uso: 6h29

fuga: 1,4 l/m

Natasha

30/08
24

P=8,6 cmH₂O

m. de uso = 5h48'

TAH=2,0 e/h

fuga = 1,4 lpm

Bem adaptado.

Juan

17/09
24

P=8,6 cmH₂O P: 8,8 cmH₂O

TAH=2,8 e/h

m de uso: 6h52'

Bem adaptado

Natasha

13/09
25

15/10/24 P=8.8cm H₂O
IAH = 2,2 e/h
m de uso: 5h 36'
fuga: 20,2 l/m

Bem adaptado
C/ poucos horas de sono
por estar dormindo
a filha
Natasha

08/01
25 P=8.8cm H₂O
IAH = 2.8 e/h
m. de uso =
Fuga = 31.9

Bem adapt.

fua.

13/05 P=8.8cm H₂O
25 IAH = 1,9 e/h
m de uso: 5h 10'
fuga: 27 l/m

uso 14/30 dias

Natasha

Nome: OTAVIO AUGUSTO MARTINS SOUSA LOPES
ROSADO
Data de Nascimento: 8-8-1992
IMC: 29,38
Sexo: Masculino
Data do exame: 26-06-2024

Peso: 91 kg
Altura: 1,76 m
Médico: DRA. PRISCILA LEITE DA
SILVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 26-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 508,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 24,5 e 142,0 minutos. O tempo total de sono foi de 454,5 min, eficiência de 89,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 63,8%; estágio N3: 11,0%; sono REM: 23,2%. O índice de despertares foi de 30,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 38,2/hora, sendo 3 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 237 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 79%, permanecendo 8,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 88 bpm e NREM de 53 - 93 bpm.

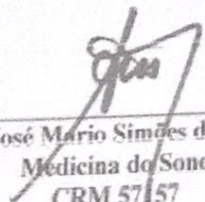
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 38,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: OTAVIO AUGUSTO MARTIS SOUSA LOPES ROSADO			
Sexo: M	Idade: 27 anos	Peso: 91 Kg	Altura: 1,76 m
IMC: 29,4	Data do Exame: 08/10/2019	Exame: 10239_01	
Médico solicitante: DR CARLOS			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:03:18 horas e encerrado às 06:00:16 horas, com latência para o sono de 18 minutos e latência para o sono REM de 293 minutos. O tempo total de sono foi de 388,0 minutos, com eficiência do sono de 80,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,2%	Até 5%
Estágio 2	85,2%	45 - 55%
Estágio 3	8,6%	> 15%
Sono REM	5,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	80,7%	> 85%

No período total de sono permaneceu 92,5 minutos acordado e ocorreram 97 micro despertares (índice de 15,0 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 61 bpm, a maior de 76 bpm e a menor de 53 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 92 eventos respiratórios, sendo 0 central, 92 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 14,2/hora, sendo 4,5 apnéia/hora e 9,7 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 36,9/hora, sendo 15,4 apnéia/hora e 21,5 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 98%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 98% e a mínima de 89%, permanecendo 0,1 minutos (0,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 90 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

Paciente: Otavio Augusto Martins Sousa Lopes Rosado

À EMPRESA DE CPAP

PACIENTE COM RNCOS E APNÉIA, SEM MELHORA COM TRATAMENTO CLÍNICO.

POLISSONO

EFICIENCIA - 89%

MICRO - 30/H

IAH:38/H

NADIR 79%

Índice de Apnéia-Hipopnéia	Índice de Saturação	Índice de Saturação
Índice de Apnéia-Hipopnéia	Índice de Saturação	Índice de Saturação
Índice de Apnéia-Hipopnéia	Índice de Saturação	Índice de Saturação
Índice de Apnéia-Hipopnéia	Índice de Saturação	Índice de Saturação
Índice de Apnéia-Hipopnéia	Índice de Saturação	Índice de Saturação

SOLICITO ADAPTAÇÃO PARA CPAP

GRATA,

Resumo dos resultados

1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de 2,5 (normal até 5,0). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
2 - Desaturação de 10%.
3 - Registro de roncocalor e 9,7 hipopnéias.
4 - Sono fragmentado pelo número de despertares (normal até 10 horas).
5 - Eficiência do sono reduzida.

Dra. Priscila L. Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140497

Priscila

Dra. Priscila Leite Da Silveira
CRM 140497 SP